

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Fisioterapia en dolor cervical

Lic.Cesar Borja Arenas

Presente.



Reconocer las principales características clínicas del dolor cervical y los lineamientos para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 08: Fisioterapia en dolor cervical

1. Concepto
2. Anatomía
3. Signos y síntomas
4. Etiología
5. Cuadros
6. Tipos
7. Valoración
8. Objetivos
9. Programa



Presente.



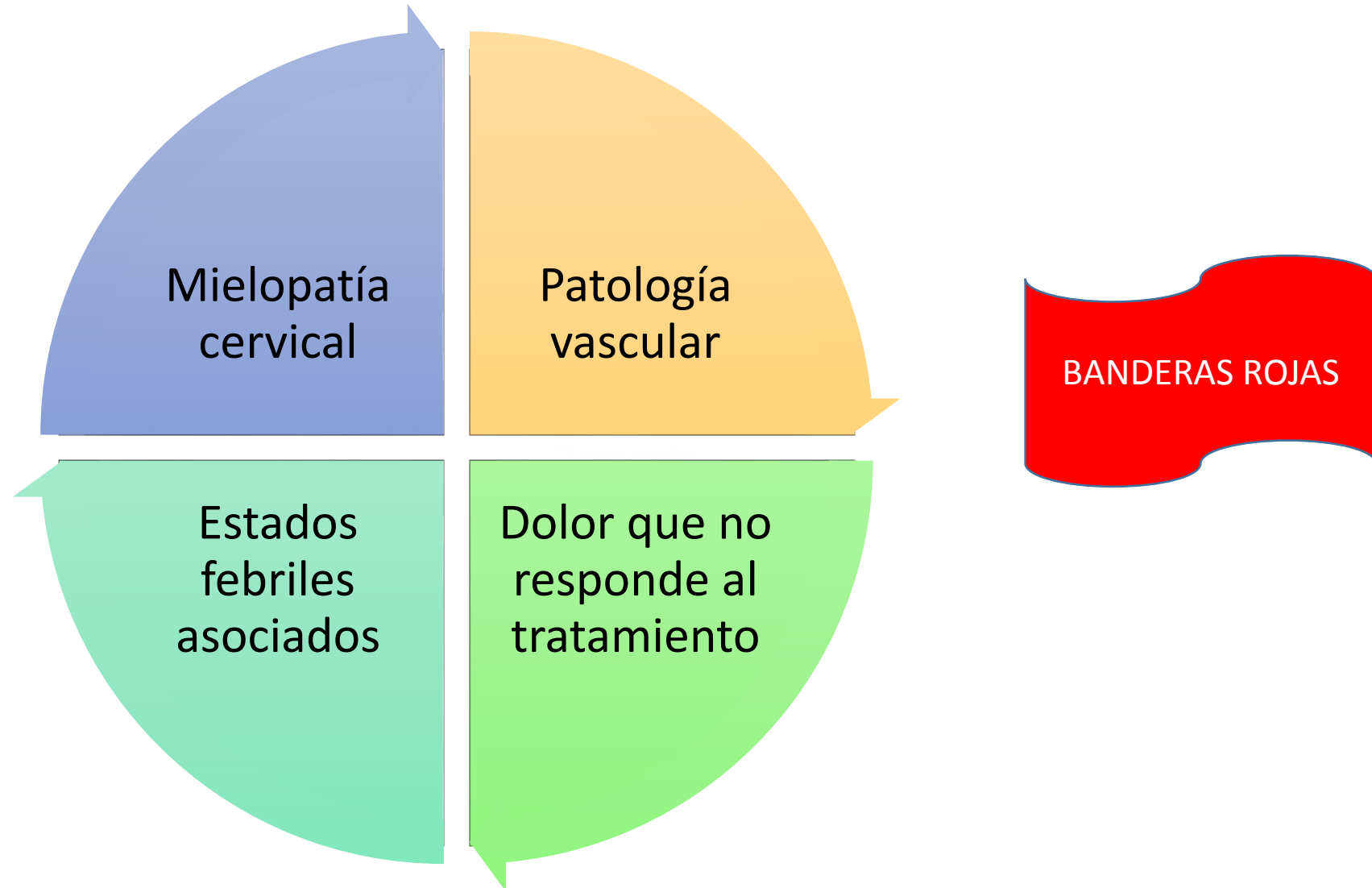


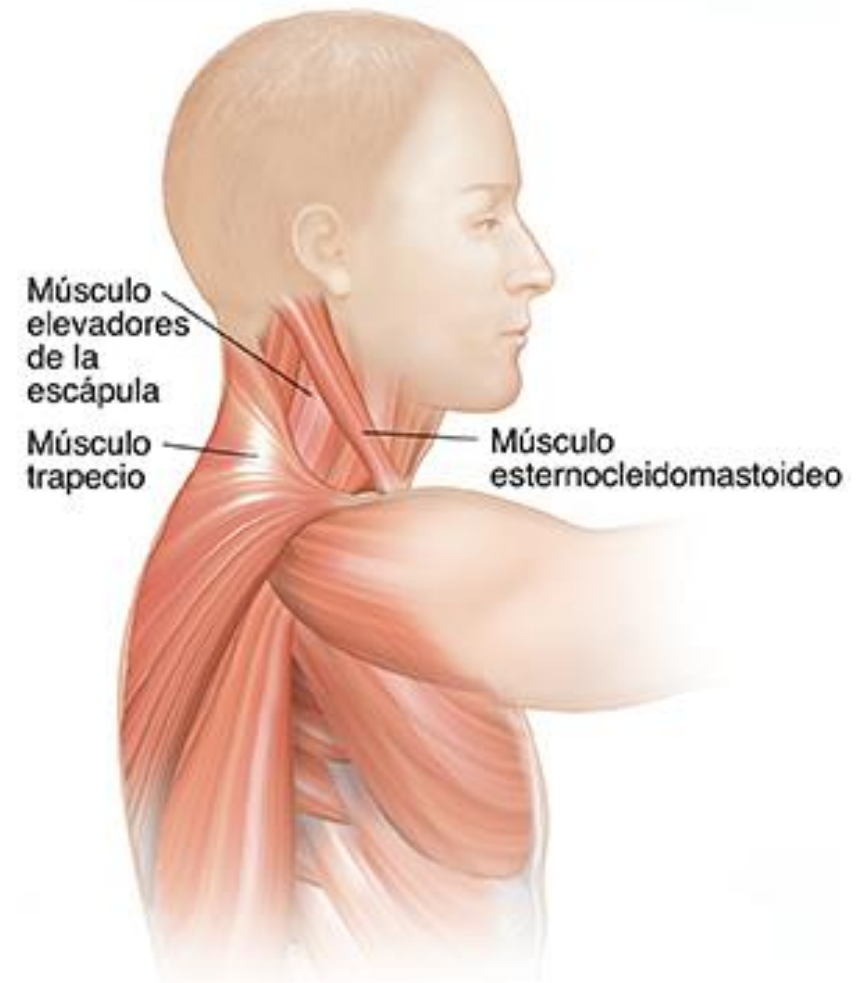
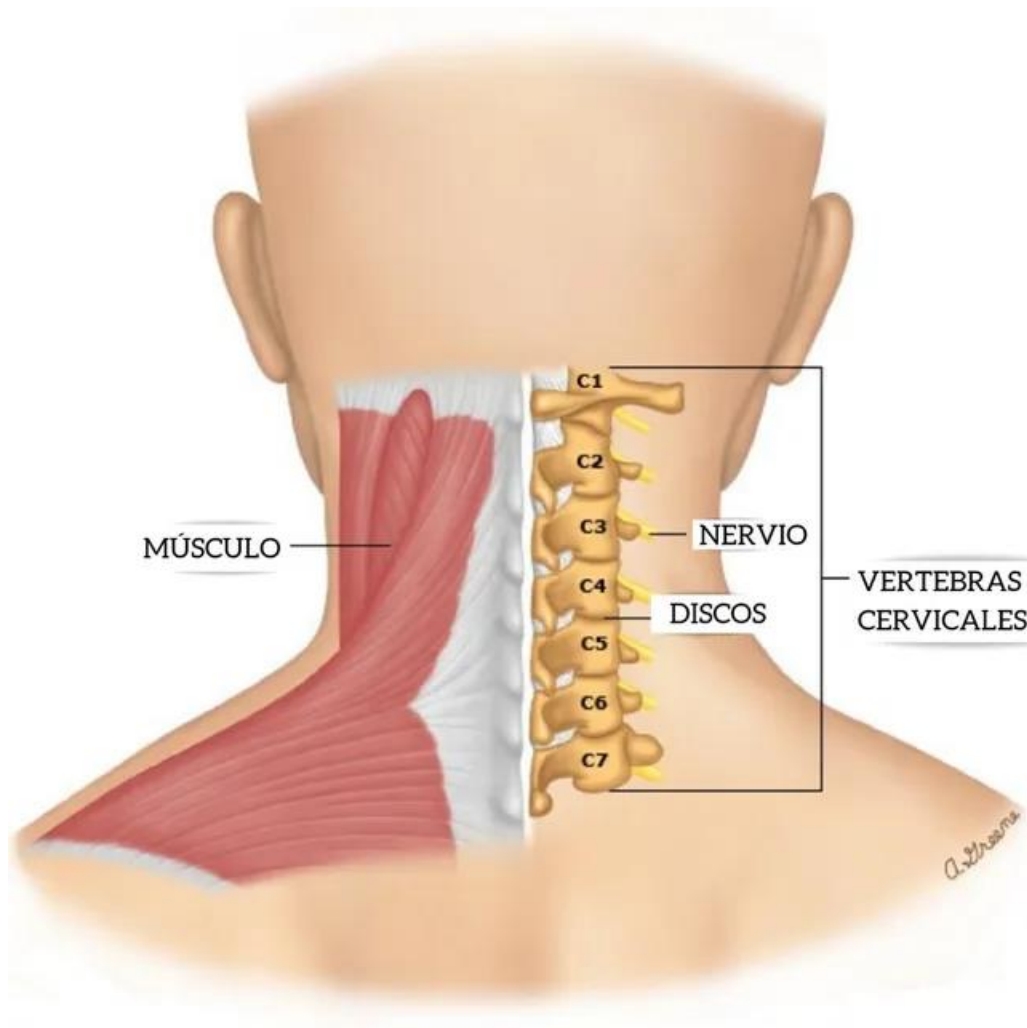
“El dolor cervical o cervicalgia es el dolor ubicado en el área anterior, posterior o paravertebral durante las funciones de inclinación, rotación y flexo-extensión del cuello ya sea localizado en estructuras musculares, óseas, viscerales o vasculonerviosas con diverso tiempo de evolución”

Dolor mecánico que se presenta en cuatro de cada cinco adultos durante su vida laboral.

La prevalencia indica que afecta aproximadamente al 10% de la población con problemas de columna.

Puede estar asociado a cefaleas y problemas vestibulares además del dolor





Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=kIQAWwCWg_4

Dolor localizado o irradiado (dorsal o miembro superior)

Contracturas musculares

Dificultad de movimiento del cuello

Disminución de fuerza muscular

Sensación de inestabilidad cervical

Cefaleas asociadas



Muscular

- Principalmente por sobrecarga, fatiga o traumatismos.
- También puede generar síntomas nerviosos por compresión.



Nervioso

- Principalmente por pinzamiento de algún nervio cervical o lesión de articulaciones intervertebrales.
- El dolor suele irradiar hacia miembro superior (cervicobraquialgia).



Traumatismos

- El principal: latigazo cervical. Flexión extrema seguida de una extensión de cuello máxima.
- Dolor de cuello, rigidez moderada-severa, cefalea, vértigo y dolor facial. Posible ruptura de músculos, ligamentos o disco.

Discopatías

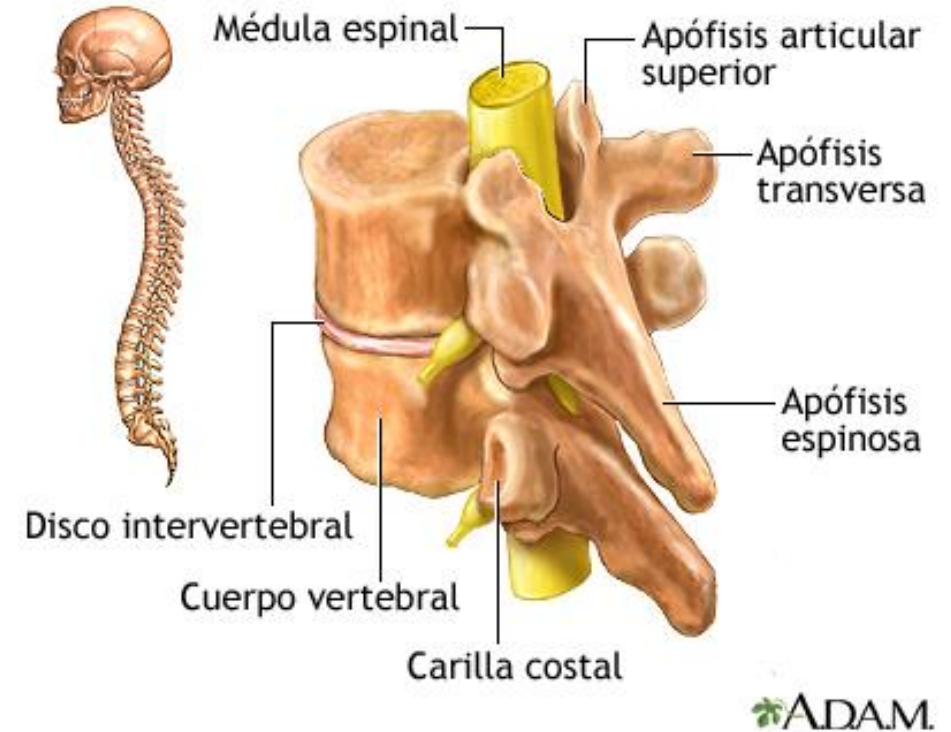
- Degeneración del disco intervertebral.
- Dolor, pérdida de fuerza, hipoestesias y parestesias en miembro superior.

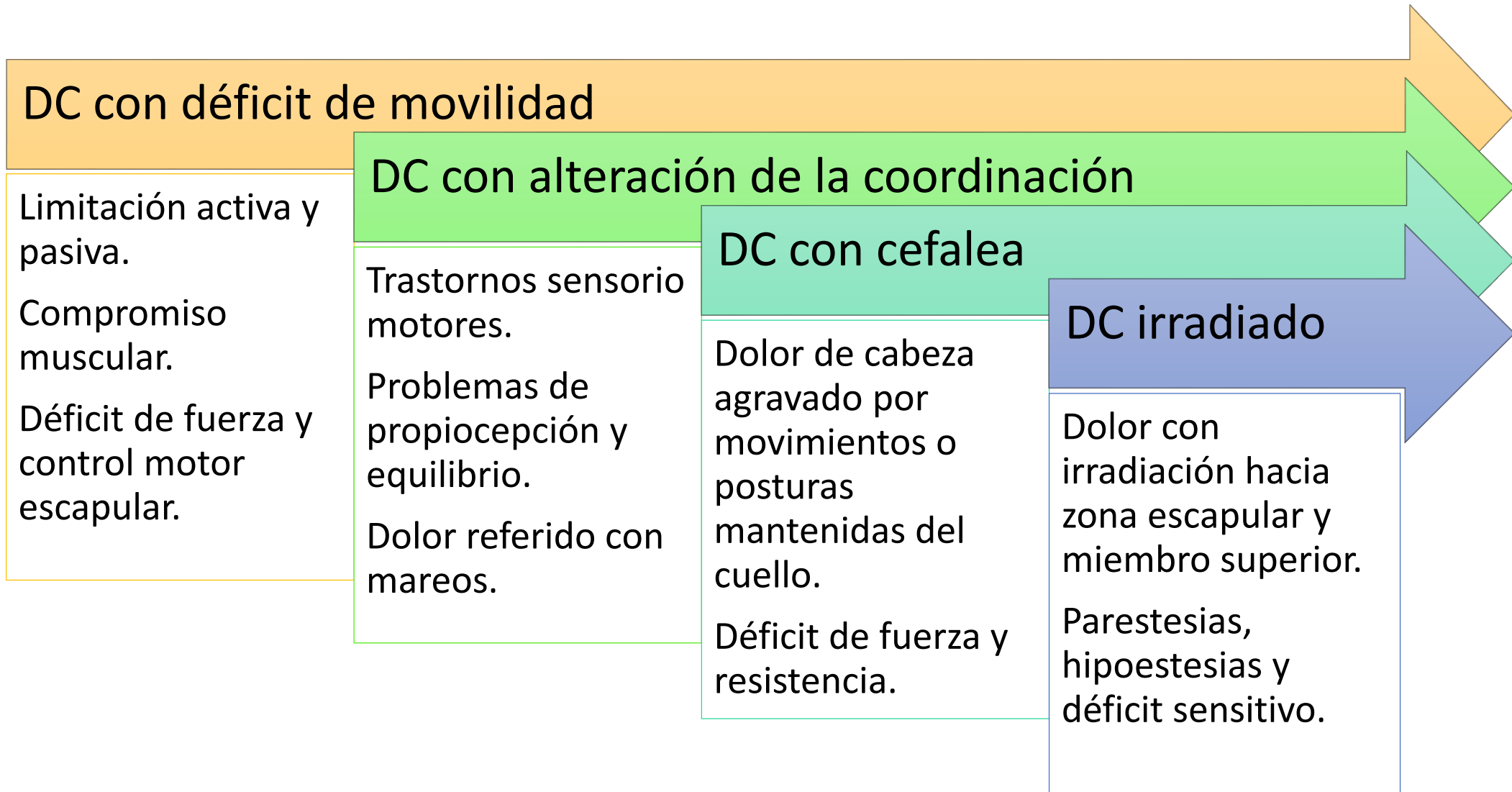
Estenosis cervical

- Estrechamiento del canal vertebral por degeneración del hueso, disco o ligamento.
- Pérdida de fuerza, sensibilidad y destreza del miembro superior, espasmos en miembro superior e incapacidad de caminar rápido.

Artrosis

- Degeneración de las vértebras cervicales (osteofitos).
- Dolor principalmente matutino e irradiación hacia el hombro.





Evaluación médica

Partes óseas: radiografía.

Partes blandas: resonancia magnética, electromiografía, entre otros

Clínica (signos y síntomas relacionados al dolor de cuello)



Figura 28: Movimientos de la columna cervical

Disminuir el dolor

Mejorar los rangos de movimiento
(flexibilidad)

Aumentar la fuerza muscular

Mejorar la funcionalidad e independencia
del paciente (ABVD-AIVD)

Disminuir dolor

Termoterapia (CHC, IR)

Electroterapia analgésica
(TENS a intensidad
acorde al paciente)

Masoterapia relajante o
descontracturante
(según evaluación)

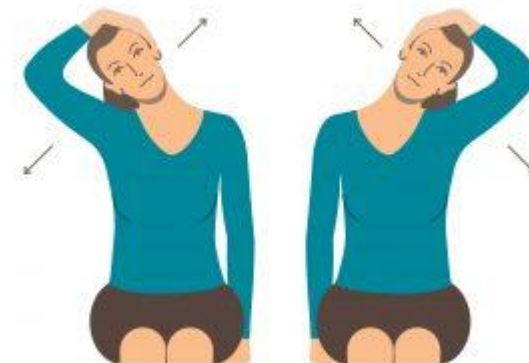


Mejorar los rangos de movimiento (flexibilidad)

Estiramientos osteomusculares progresivos (cuello)

Estiramientos osteomusculares progresivos (hombro, tórax y columna dorsal)

Movilizaciones pasivas de columna cervical – Tracciones (según evaluación)



Aumentar la fuerza muscular

Ejercicios libres de
flexo-extensión,
rotación e inclinación
de cuello

Ejercicios isométricos
de musculatura
estabilizadora de
cuello

Ejercicios resistidos
(bandas) de
musculatura escapular



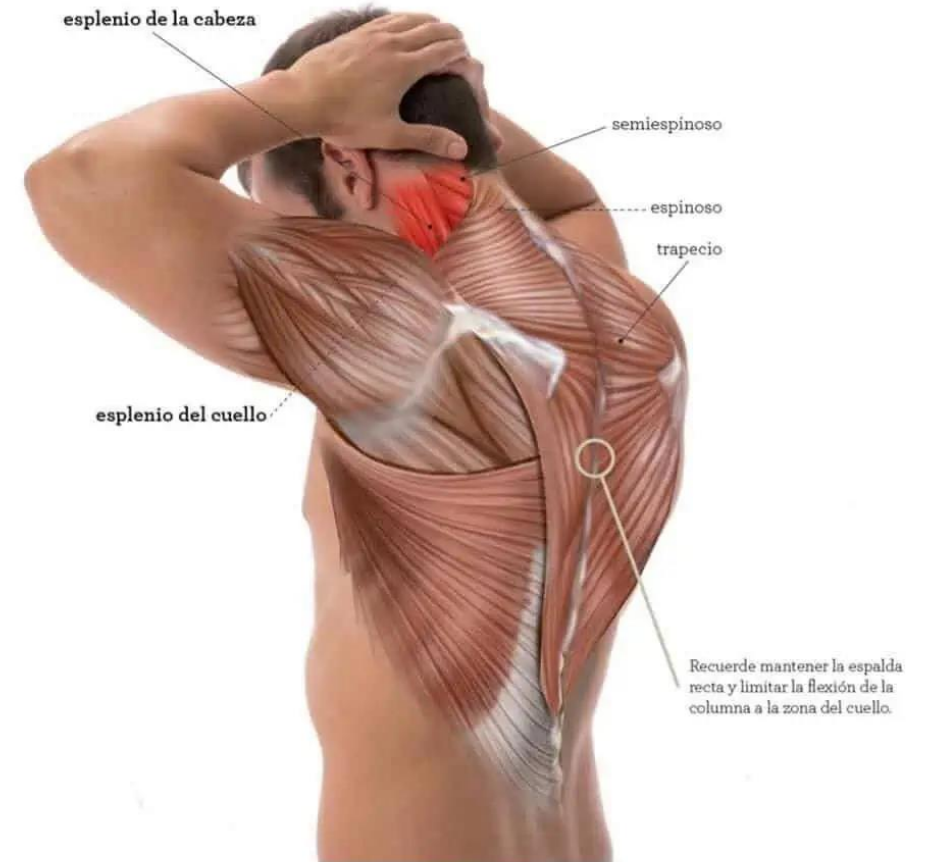
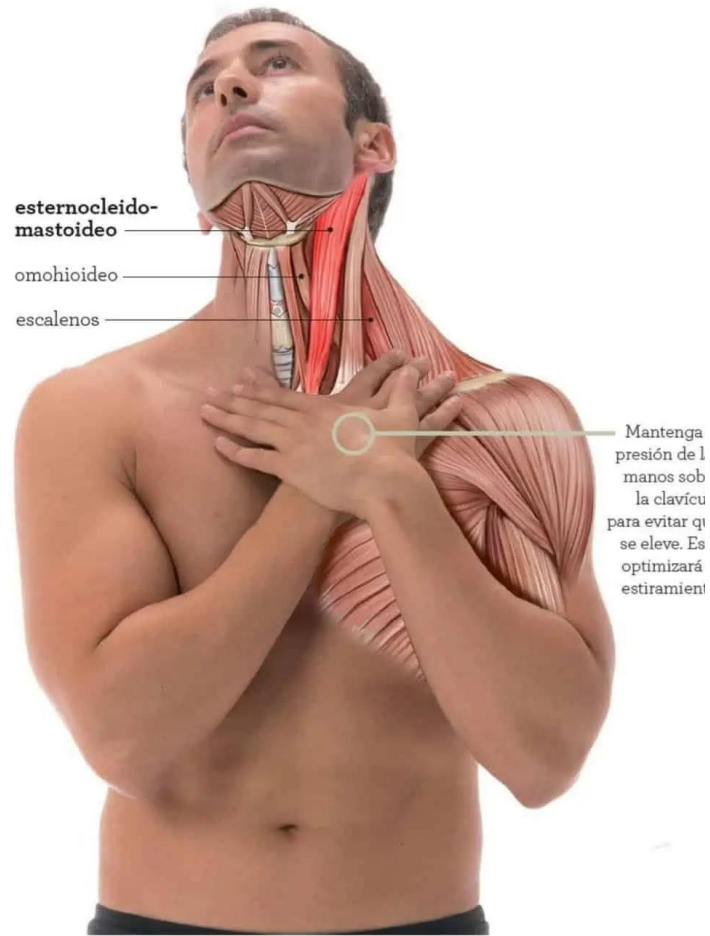
© Healthwise, Incorporated

Mejorar la
funcionalidad e
independencia
del paciente
(ABVD-AIVD)

Realizar cambios
ergonómicos
relacionados al trabajo
(sillas, mesas,
computadora, etc.)

Realizar actividades que
impliquen trabajo
muscular cervical en
funciones diarias

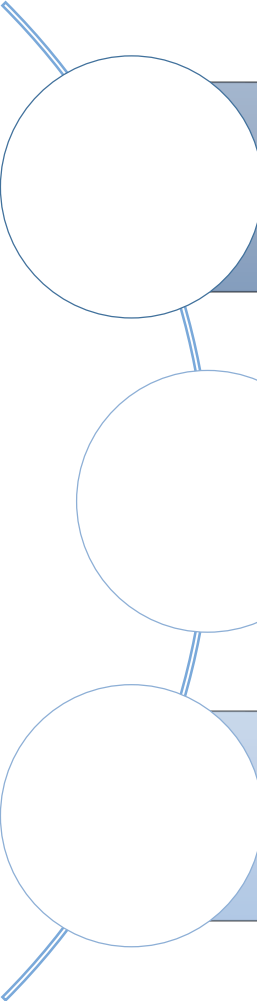




ESTIRAMIENTOS BÁSICOS

Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=f5GgK5Vij-o>

Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=-Fmth0HD9yw>



1. EL DOLOR CERVICAL PUEDE PRODUCIRSE POR UN MOVIMIENTO EXCESIVO DE LA FLEXIÓN, EXTENSIÓN, ROTACIÓN O INCLINACIÓN. ASIMISMO, PUEDE ESTAR ASOCIADO A CEFALÉAS, MAREOS Y PÉRDIDA DEL EQUILIBRIO.

2. LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS COMUNES DEL DOLOR CERVICAL SON LAS CONTRACTURAS, INESTABILIDAD Y DISMINUCIÓN DE LA FUERZA. ADEMÁS PUEDEN TENER UNA ETIOLOGÍA MUSCULAR Y NERVIOSA.

3. EXISTEN 4 TIPOS DE DOLOR CERVICAL: IRRADIADO, CON CEFALÉA, CON DÉFICIT DE COORDINACIÓN Y DÉFICIT DE MOVILIDAD.

- <https://www.redalyc.org/pdf/304/30401207.pdf>
- <https://eprints.ucm.es/id/eprint/71752/1/Evaluacio%CC%81n%20y%20clasificacio%CC%81n%20del%20dolor%20cervical%20en%20fisioterapia.pdf>
- <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/629GER.pdf>
- <https://sochire.cl/wp-content/uploads/2021/09/r-484-1-1343957978.pdf>

Presente.

PREGUNTAS ACLARACIONES INTERVENCIONES



Caso clínico: Erick Sarmiento es un nadador profesional de 28 años; después de su última competencia el 15 de junio de 2023 comenzó con dolores progresivos en la zona posterior del cuello e irradiación hacia la zona interescapular. Tras la evaluación clínica y ecográfica del médico del deporte se determinó que presentaba un caso de cervicalgia mecánica debido a una sobrecarga muscular. En la valoración fisioterapéutica, el Lic. T.M. halló dolor a la palpación y mayor tensión muscular en trapecios superiores, esternocleidomastoideos, esplenios y pectorales mayores. Actualmente la intensidad de dolor se encuentra entre un 6 a 7 (EVA) y el paciente presenta limitaciones para extender completamente la cabeza y para sus rotaciones. Según ello, plantee tres estrategias para:

- Incrementar el rango de movimiento (estiramientos musc.)
- Aumentar la fuerza muscular (ej. de fortalecimiento)
- Mejorar la funcionalidad (reinserción deportiva)



MUCHAS GRACIAS

Presente.